



态,且未出现低血糖反应。

2.2.2 实验研究 孙志等^[26]实验发现针刺糖尿病模型大鼠足三里、内庭、胰俞,与使用罗格列酮灌胃,在血糖、血脂无显著差异,针刺组胰岛 β 细胞胰岛素表达显著高于西药组 ($P<0.05$),说明针刺可显著提高2型糖尿病模型大鼠胰岛 β 细胞胰岛素表达水平,有效改善胰岛 β 细胞功能。王栩等^[27]“调理脾胃针法”干预2型糖尿病大鼠,结果实验组大鼠体质量仍明显高于空白组 ($P<0.05$);空腹血糖及餐后2 h血糖于针刺1周后开始显著降低 ($P<0.01$),后续实验空腹血糖及餐后2h血糖均仍有持续显著降低 ($P<0.01$),说明针刺可有效降低大鼠空腹及餐后2 h血糖,可能与提高胰岛素敏感性,改善胰岛素抵抗现象等有关。基于针刺具有调整激素、内分泌等功能,研究发现,针刺治疗消渴主要作用途径包括改善胰岛素抵抗、保护胰岛 β 细胞等多环节、多层次作用。

3 展望

随着生活方式和饮食结构的改变,糖尿病发病率呈逐年上升趋势,若血糖控制不理想,极易诱发各种合并症,如糖尿病坏疽、糖尿病眼病等,严重影响身体健康和生活品质。西医治疗注意以控制血糖为主,并不能从根本上解决问题。中医药治疗具有独特优势,针对消渴不同时期病机不同及病机衍化,辨证论治,标本兼顾,治疗方法多样化,因人因病机,投以方剂或针刺,从根本上调节脏腑,阴平阳秘,精神乃治。未来应继续扩大中医药治疗消渴的应用范围,探索其作用机制,充分发挥中医学的优势,为糖尿病的治疗提供新的方向。

参考文献

- [1]陆再英,终南山.内科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2008:775.
- [2]中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2013年版)[J].中华内分泌代谢杂志,2014,30(10):447-498.
- [3]杨玉莲,孙新宇.黄连温胆汤加味治疗肥胖型消渴30例[J].中医研究,2007,20(4):48-49.
- [4]刘之涌.消渴病病因病机研究进展[D].广州:广州中医药大学,2015.
- [5]袁力,曹金枝,陆芝兰,等.379例II型糖尿病中医辨证分型与胰岛素抵抗相关因素分析[J].现代中医临床,2002,9(1):6-9.
- [6]贾海骅,赵红霞,赵凯维,等.探讨糖尿病(消渴)中医病因病机[J].中国中医基础医学杂志,2012,18(1):22.
- [7]王宝瑞.消渴方加减治疗2型糖尿病阴虚热盛型36例[J].内蒙古中医药,2010,29(15):58.
- [8]李秀夏.消渴方加减治疗2型糖尿病82例疗效观察[J].中国医药指南,2010,8(5):60-61.
- [9]杨玲.中药消渴方联合西药治疗2型糖尿病疗效观察[J].中医临床研究,2014,6(19):114-115.
- [10]周永华,蔡亮,玉女煎加减治疗消渴病中消证临床疗效观察[J].中国民间疗法,2016,24(4):64-65.
- [11]何才姑,钱长晖,黄玉梅,等.玉女煎对GK大鼠胰岛自噬基因Beclin表达的影响[J].康复学报,2012,22(2):32-35.
- [12]秦姝,李小娟.李小娟教授应用玉女煎治疗消渴病验案2则[J].辽宁中

医药大学学报,2010,12(4):147-148.

- [13]李占伟.七味白术散治疗消渴病临床疗效研究[J].亚太传统医药,2014,10(7):111-112.
- [14]方为民.七味白术散加减治疗消渴体会[J].黔南民族医学学报,2014,27(2):106-108.
- [15]吴冬意.六味地黄丸治疗糖尿病临床应用研究[J].中国民族民间医药,2011,20(20):81-82.
- [16]和发新,李庆芳,杨继芬.六味地黄丸联合瑞格列奈治疗2型糖尿病疗效观察[J].基层医学论坛,2013,17(13):1735-1736.
- [17]焦永伟.金匮肾气丸治疗消渴53例疗效观察[J].医学理论与实践,2012,25(1):47-48.
- [18]孙凤平,谢春光,钞建锋.金匮肾气丸治疗消渴病的机理及使用误区[J].辽宁中医药大学学报,2011,13(2):124-125.
- [19]牟新.金匮肾气丸治疗消渴病机理新探[J].实用中医内科杂志,2004,18(5):381.
- [20]范晨.针刺治疗糖尿病肾病古代穴位浅探及现代临床研究[D].广州:广州中医药大学,2011.
- [21]许林玲,徐天舒,张建斌.基于数据挖掘技术探讨古代针灸治疗消渴病的腧穴配伍规律[J].中国针灸,2015,35(8):841-843.
- [22]谢瑞仁.针灸治疗消渴病的选穴规律文献研究[D].广州:广州中医药大学,2014.
- [23]刘京丽,胡金凤.管窥消渴之针灸诊治要点[J].辽宁中医杂志,2011,38(10):2001-2002.
- [24]刘京丽.针灸治疗消渴的时间效应研究[J].长春中医药大学学报,2012,28(5):861-862.
- [25]陈万泓.针刺“消渴组穴”改善2型糖尿病特异性生命质量的临床观察研究[D].北京:北京中医药大学,2013.
- [26]孙志,马丽,韩海荣,等.针刺提高2型糖尿病模型大鼠胰岛 β 细胞胰岛素的表达[J].中国组织工程研究,2012,16(28):5227-5231.
- [27]王栩,张智龙,杨元庆,等.针刺对2型糖尿病大鼠胰岛素抵抗及胰岛 β 细胞形态学的影响[J].南京中医药大学学报,2016,32(1):45-49.

(本文编辑 孙俊俊 本文校对 张天仁 收稿日期 2017-07-20)

桑白皮的鉴别要点

1. 药材鉴别

药材呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状,厚1~4 mm,长短不一。外表面白色或淡黄白色,较平坦,有的残留橙黄色或棕黄色鳞片状粗皮;内表面黄白色或灰黄色,有细纵纹。体轻,质韧,纤维性强,难折断,易纵向撕裂,撕裂时有粉尘飞扬。气微,味微甜。

2. 饮片鉴别

饮片呈不规则横切丝状,外表面黄白色有时可见黄棕色粗皮,内表面淡黄白色,有细纵纹,体轻,质韧,断面纤维性强,易纵向撕裂,撕裂时有粉尘飞扬。气微,味微甜。蜜炙桑白皮,呈深黄色,气焦香,味甜。

3. 解读市场中流通的桑白皮入药品种

关于桑根皮的品种问题:目前市面上作桑皮入药的非正常品种有桑科植物鸡桑 *Morus australis* Poir. 华桑 *Morus cathayana* Hemsl. 蒙桑 *Morus mongolica* Schneid. 和桑科植物构树 *Broussonetia papyrifera* (Linn.) Vent. 桑科植物 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) Bur. 等的根皮,药学人员要注意鉴别。

——摘自祝之友教授《解读神农本草经》